

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γενικά: Στις περισσότερες περιπτώσεις η πάρεση αφορά στην ιδιοπαθή “*παράλυση Bell*”. Η παράλυση Bell πιθανώς οφείλεται σε ένα παροδικό οίδημα, που λαμβάνει χώρα εντός του φαλλοπιανού πόρου από όπου διέρχεται το νεύρο (VII). Πιστεύεται μάλιστα ότι αυτό το οίδημα προκαλείται συχνότερα από την απότομη έκθεση σε ψύχος και για αυτόν το λόγο ονομάζεται «*παράλυση εκ ψύξεως*». Υπάρχουν όμως κι άλλα αίτια, που ενοχοποιούνται για τη μονόπλευρη πάρεση του προσωπικού νεύρου, συχνότερα των οποίων είναι τα κάτωθι:

- | | |
|--|--|
| ▶ Όγκοι γεφυρο-παρεγκεφαλ/κής γωνίας. | ▶ Σύνδρομο Guillian-Barre. Μυασθένεια. |
| ▶ Έρπης ζωστήρας - VZV (<i>Ramsay Hunt</i>). | ▶ Σακχαρώδης διαβήτης. |
| ▶ Λοίμωξη από HSV, EBV, CMV, κ.ά. | ▶ Σαρκοείδωση. Νόσος Wegener. |
| ▶ Μαστοειδίτιδα / Λιθοειδίτιδα. | ▶ N. Lyme. Τέτανος. Τραύμα. |

Κύρια συμπτώματα:

1. Ασυμμετρία του προσώπου. Ασύμμετρο χαμόγελο.
2. Πτώση της γωνίας του στόματος στην πάσχουσα πλευρά.
3. Πτώση της οφρύος στην πάσχουσα πλευρά.
4. Εξαφάνιση των ρυτίδων στο μέτωπο και τα μάγουλα, ομόπλευρα.
5. Αδυναμία σύγκλεισης των βλεφάρων στη πάσχουσα πλευρά.
6. Ανεξέλεγκτη δακρύρροια από το μάτι της πάσχουσας πλευράς.
7. Αδυναμία σύσφιξης των χειλέων ή διατήρησης της τροφής στο στόμα.



Ελέγχουμε για ύπαρξη κι άλλων συνοδών συμπτωμάτων, όπως διαταραχές γεύσης, εμβοές, βαρηκοΐα, ίλιγγος, έλλειψη δακρύων, διπλωπία, κ.ά. Αξιολογώντας τα κλινικά ευρήματα, θα αποφασίσουμε για διενέργεια εξετάσεων (γεν. αίματος, *Glu*, *Urea*, *Creat.*, Na^+ , K^+ , Ca^{++} , *CRP*, *TKE*, *IgM/IgG*, κ.ά.) και για τη διενέργεια CT λιθοειδών ή/και CT ή MRI εγκεφάλου.

Ενημερώνουμε τον ασθενή για το συμβάν, την κλινική εικόνα, τη διάρκεια της θεραπείας και για το ενδεχόμενο ότι ίσως θα αρχίσει να βλέπει αισθητή βελτίωση μετά από 1-2 μήνες.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Χορηγούμε Πρεδνιζολόνη ή Μεθυλπρεδνιζολόνη, σε σχήμα αποκλιμάκωσης, δηλαδή:
 - tab. **Prezolon** 5 mg, για 10 ημέρες, (3x4 x5d → 2x4 x2d → 1x4 x2d → 1x2 x1d), ή
 - tab. **Medrol** 16 mg, για 10 ημέρες, (1x4 x5d → 1x3 x2d → 1x2 x2d → 1x1 x1d).
2. Ακυκλοβίρη (Βαλασικλοβίρη) ή Φαμισικλοβίρη, επί υποψίας ερπητολοίμωξης, ήτοι:
 - tab. **Zovirax** 400 mg, 1x5, ή tab. **Valtrex** 1000 mg, 1x3, αμφότερα για 7 ημέρες, ή
 - tab. **Famvir/Famcilet** 500 mg, 1x3, για 7 ημέρες.
3. Χορηγούμε σκευάσματα «νευροτροφικών» βιταμινών, του συμπλέγματος B (*B1*, *B6*, *B12*).
 - tab. **Neurobion** (100/200/0,2) mg, 1x3 μετά τα γεύματα, για 1-2 μήνες.
4. Για τους οφθαλμούς, χορηγούμε γέλη ή κολλύριο, προς αποφυγήν της ξηροφθαλμίας:
 - γέλη **Dacrio Gel** 0,3%, 2 επαλείψεις ανά 8ωρο, για 15-30 ημέρες, ή
 - coll. **Refresh plus** ή **Vidilac** ή **Tears Natural**, 2 σταγόνες x4 ή x6, για 15-30 ημέρες.Το βράδυ, κατά την κατάκλιση, καλύπτουμε το μάτι με γάζα, αφού αλείψουμε με γέλη.
5. Συστήνουμε στον ασθενή, να μασάει τσίχλα, για 8-10 ώρες την ημέρα, για 7-10 ημέρες.
6. Χορηγούμε, ενίοτε, αναλγητικά/ΜΣΑΦ (*Depon*, *Lonarid-N*, *Arcoxia*, *Xeфо*) για το άλγος στη μαστοειδή ή πέριξ του ωτός, που συχνά προηγείται της πάρεσης κατά 1-3 ημέρες.
7. Η θεραπεία για να αποβεί αποτελεσματική πρέπει να αρχίσει άμεσα ή το αργότερο εντός των πρώτων 2-3 ημερών από την εγκατάσταση των συμπτωμάτων. Αν όμως η θεραπεία καθυστερήσει και ξεκινήσει αργότερα από τις 7-10 ημέρες, τότε μειώνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητά της. Σε περιπτώσεις μη επαρκούς θεραπείας ή/και ελλειμματικής αποκατάστασης της λειτουργίας του νεύρου, σε 15-21 ημέρες περίπου, είναι αναγκαία η φυσιοθεραπευτική αγωγή με ηλεκτροδιέγερση του πάσχοντος νεύρου και απαραίτητη η επικοινωνία με ιατρό ΩΡΛ, για περαιτέρω λήψη συμβουλών ή παραπομπή του ασθενούς.